RESET IGD

Rapid Emotional Support and Energy Transition

Dukungan Singkat bagi Pemulihan Petugas setelah Situasi Bertekanan Tinggi di Instalasi Gawat Darurat RS Mutiara Sukma

Karya Tulis Case Solving RSMS 2026

Nama	: dr. Baiq Karina Chaswin & dr. Wahyu Gading Maulana
Unit Kerja	: Instalasi Gawat Darurat

1. Latar Belakang

Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan unit dengan tekanan kerja yang tinggi. Setelah suatu situasi kegawatdaruratan berhasil dikendalikan, pelayanan kepada pasien berikutnya tetap harus dilanjutkan, sering kali tanpa jeda yang memadai. Ketegangan setelah penanganan pasien gelisah atau agresif, keluarga pasien dengan emosi tinggi, maupun kejadian pelayanan yang berat dapat terbawa ke tugas berikutnya, sementara kesiapan petugas untuk kembali bertugas jarang ditanyakan.

Paparan semacam ini tidak tergolong langka. Sebuah meta-analisis melaporkan bahwa 61,9% tenaga kesehatan mengalami kekerasan di tempat kerja dalam satu tahun terakhir, termasuk kekerasan fisik pada 24,4% tenaga kesehatan, dengan prevalensi yang tinggi di IGD dan layanan psikiatri [1]. Kesejahteraan petugas yang buruk dan *burnout* juga dikaitkan dengan keselamatan pasien yang lebih rendah [2].

Dari sisi regulasi, pelindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan, serta pelindungan dari perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat, ditetapkan sebagai hak tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan [3]. Bahaya psikososial juga dicantumkan sebagai salah satu potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan [4]. Penerapan intervensi tingkat organisasi untuk mengurangi risiko psikososial di tempat kerja juga dianjurkan oleh WHO, sehingga pemulihan petugas tidak sepenuhnya dibebankan kepada individu [5].

Kebutuhan tersebut juga dijumpai di IGD RS Mutiara Sukma. Dalam pengalaman pelayanan, pernah ditangani pasien gelisah yang kondisinya meningkat hingga merusak barang. Setelah situasi dinyatakan aman, perhatian lebih banyak dicurahkan pada pemulihan pelayanan, sedangkan kebutuhan petugas untuk memulihkan ketenangan belum ditangani secara terstruktur. Kejadian ini digunakan sebagai contoh pemicu tekanan; fokus karya ini diletakkan pada dukungan bagi petugas setelah kejadian, bukan pada tata laksana pasien gelisah.

Kesempatan untuk mengambil jeda juga terbatas. Pada *shift* siang dan malam, pelayanan dijalankan oleh dua perawat, dan pada malam hari hanya satu dokter jaga yang bertugas. Dengan komposisi tersebut, penggantian sementara dari dalam tim tidak selalu dapat dilakukan, sehingga bentuk dukungan yang mengharuskan petugas meninggalkan area pelayanan setiap kali dibutuhkan sulit diterapkan. Berdasarkan kondisi tersebut, RESET IGD diusulkan sebagai mekanisme dukungan singkat yang fleksibel dan dapat dijalankan tanpa mengganggu kesinambungan pelayanan.

Rumusan masalah. Bagaimana dukungan singkat dapat disediakan untuk membantu petugas IGD memulihkan ketenangan dan kesiapan bertugas setelah kejadian bertekanan tinggi, di tengah terbatasnya jumlah tenaga dan kesempatan jeda?

Tujuan. Secara umum, usulan ini ditujukan agar tersedia mekanisme dukungan yang mudah dan aman diterapkan setelah situasi bertekanan tinggi di IGD RS Mutiara Sukma. Secara khusus, melalui usulan ini: (1) penyampaian kebutuhan dukungan oleh petugas dipermudah; (2) kebiasaan saling menawarkan bantuan antarrekan dibangun; (3) kesempatan pemulihan disediakan sesuai kondisi pelayanan; dan (4) kebutuhan bantuan lanjutan dikenali dan ditindaklanjuti lebih awal.

2. Identifikasi dan Dampak Masalah

2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan berdasarkan pengalaman pelayanan dan masukan petugas IGD. Empat kondisi utama ditemukan, yaitu: (1) kelelahan dan ketegangan setelah penanganan pasien gaduh atau agresif; (2) sulitnya mengambil jeda ketika *shift* sedang ramai; (3) tekanan setelah menghadapi keluarga pasien atau kejadian berat; dan (4) dukungan antarrekan yang masih bergantung pada inisiatif pribadi. Akar masalah kemudian dianalisis berdasarkan empat faktor sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis akar masalah

Faktor	Temuan	Kebutuhan perbaikan
Sumber daya manusia	Hanya dua perawat bertugas pada *shift* siang dan malam, serta satu dokter jaga pada malam hari; penggantian sementara sulit dilakukan.	Bentuk dukungan yang fleksibel dan jeda yang disesuaikan dengan cakupan tugas.
Metode/prosedur	Belum tersedia alur dukungan bagi petugas setelah kejadian berat; kesiapan kembali bertugas belum ditanyakan secara rutin.	Alur singkat yang disepakati bersama, termasuk pemeriksaan kesiapan dan tindak lanjut.
Budaya kerja dan komunikasi	Kebutuhan bantuan berpotensi tidak disampaikan karena rasa sungkan; bantuan bergantung pada inisiatif masing-masing.	Kalimat sederhana untuk meminta dan menawarkan bantuan tanpa stigma.
Sarana	Belum tersedia panduan tertulis maupun pengingat visual; tempat istirahat tidak selalu dapat dimanfaatkan saat pelayanan berjalan.	Kartu saku dan poster alur RESET; pemanfaatan fasilitas yang sudah ada.

2.2 Dampak Masalah

Apabila tidak ditangani, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak pada tiga tingkat sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Dampak yang berpotensi timbul

Tingkat	Uraian dampak
Petugas	Ketegangan terbawa ke tugas berikutnya, kelelahan emosional bertambah, dan risiko *burnout* meningkat apabila paparan terjadi berulang tanpa kesempatan pemulihan.

Tingkat	Uraian dampak
Pasien dan mutu pelayanan	Konsentrasi dan komunikasi dengan pasien berikutnya dapat terganggu. Dalam tinjauan sistematis, *burnout* dikaitkan secara bermakna dengan keselamatan pasien pada 21 dari 30 studi yang menilai keduanya [2].
Tim dan rumah sakit	Budaya saling mendukung tidak terbangun, dan pemenuhan hak pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja petugas, termasuk terhadap bahaya psikososial, belum optimal [3,4].

Besaran dampak tersebut di IGD RS Mutiara Sukma belum diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu, pengukuran awal dimasukkan ke dalam rencana implementasi, dan dampak di atas tidak diklaim sebagai hasil yang telah terjadi.

3. Alternatif Solusi

3.1 Pemilihan Alternatif

Empat alternatif dibandingkan menggunakan kriteria solusi yang ditetapkan dalam ketentuan lomba, yaitu kreatif dan inovatif (K), realistis untuk diterapkan (R), sesuai dengan kondisi RS Mutiara Sukma (S), serta memiliki dampak positif yang jelas (D). Setiap kriteria diberi skor 1 (rendah) sampai 3 (tinggi) berdasarkan penilaian penyusun terhadap kondisi IGD.

Tabel 3. Perbandingan alternatif solusi

Alternatif	Kelebihan dan keterbatasan	K	R	S	D	Total
Edukasi pengelolaan stres	Pengetahuan petugas bertambah; namun dukungan belum tentu tersedia pada saat dibutuhkan setelah kejadian.	1	3	2	1	7
Ruang istirahat khusus	Kenyamanan meningkat; namun ruang dan biaya diperlukan, dan ruang tidak dapat dimanfaatkan bila tugas belum tercakup.	1	1	1	2	5
Rujukan konsultasi profesional	Bantuan sesuai kebutuhan individu; namun pengaturan akses dan waktu diperlukan sehingga tidak bersifat segera.	1	2	2	2	7
RESET IGD	Dapat segera dimulai melalui kesepakatan tim, tanpa ruangan atau biaya besar, dan disesuaikan dengan jumlah tenaga; manfaatnya perlu dibuktikan melalui uji coba.	3	3	3	2	**11**

RESET IGD dipilih karena memperoleh skor tertinggi. Edukasi dan konsultasi profesional tidak ditinggalkan, tetapi diintegrasikan sebagai komponen pelengkap: edukasi diberikan saat sosialisasi, sedangkan konsultasi profesional digunakan sebagai jalur tindak lanjut.

3.2 Rancangan Solusi Terpilih: RESET IGD

RESET IGD merupakan program lokal yang disusun dengan mengadaptasi tiga pendekatan yang telah digunakan di layanan kesehatan, yaitu dukungan sebaya bagi petugas setelah kejadian bertekanan (program RISE) [6], *hot debrief* lima menit di IGD (STOP5) [7], dan prinsip *psychological first aid* [8]. Unsur kebaruan RESET terletak pada penyesuaiannya dengan IGD yang berpetugas sedikit: dukungan tidak mensyaratkan seluruh tim berhenti bekerja dan dapat dimulai di tempat, sedangkan jeda

terpisah hanya diberikan bila tugas tetap tercakup. Lima langkah RESET digunakan sebagai pengingat operasional, bukan sebagai instrumen diagnosis atau protokol terapi (Tabel 4).

Tabel 4. Langkah RESET IGD

Langkah	Pelaksanaan	Contoh kalimat atau tindakan
R — *Recognize*	Kebutuhan dukungan dikenali, baik melalui penyampaian petugas sendiri maupun tawaran dari rekan.	"Aku masih tegang setelah kejadian tadi, perlu waktu sebentar." / "Tadi cukup berat. Ada yang bisa kubantu?"
E — *Ensure safety*	Situasi dipastikan aman dan cakupan tugas dipastikan tersedia sebelum petugas meninggalkan area pelayanan.	Pasien sudah tertangani, keamanan sudah terkendali, dan tugas diserahkan sementara kepada rekan.
S — *Short pause*	Kesempatan berhenti sejenak diberikan sesuai kondisi pelayanan dan pilihan petugas (rancangan awal 3–5 menit).	Duduk, minum, menarik napas perlahan, atau mengambil waktu tenang.
E — *Emotional support*	Bantuan praktis ditawarkan, dan petugas didengarkan bila ingin berbicara, tanpa diminta menceritakan ulang kejadian.	Tugas yang tertunda dibantu diselesaikan; petugas didengarkan tanpa dihakimi.
T — *Transition*	Kesiapan melanjutkan tugas ditanyakan, dan kebutuhan bantuan lanjutan dikenali.	"Sudah siap melanjutkan, atau masih perlu bantuan?"

Prinsip pelaksanaan berikut disepakati dalam tim:

- Dukungan bersifat sukarela, dan penolakan tawaran dukungan dihormati.
- Tawaran disampaikan secara pribadi, tanpa label atau penilaian terhadap kemampuan petugas.
- Petugas tidak diwajibkan menceritakan kembali kejadian, sejalan dengan *psychological first aid* yang menekankan penghormatan terhadap martabat dan pilihan orang yang dibantu [8].
- Isi percakapan dijaga kerahasiaannya dan tidak dicatat.
- Kesinambungan pelayanan pasien tetap diutamakan; bentuk dukungan disesuaikan dengan kondisi pelayanan (Tabel 5).

Tabel 5. Penyesuaian bentuk dukungan dengan kondisi pelayanan

Kondisi pelayanan	Bentuk dukungan
Tugas dapat dicakup rekan	Jeda terpisah 3–5 menit diberikan di ruang jaga atau tempat yang tenang; durasi dapat disesuaikan.
Tugas belum dapat dicakup (misalnya kedua perawat masih dibutuhkan)	Dukungan singkat dimulai di tempat ketika tugas klinis memungkinkan; jeda dijadwalkan ulang oleh penanggung jawab *shift*.
Petugas tidak mampu melanjutkan tugas dengan aman	Penanggung jawab *shift* atau atasan langsung segera dihubungi untuk pengaturan bantuan tenaga sesuai mekanisme rumah sakit; kondisi ini tidak diselesaikan dengan menunggu jeda.
Dibutuhkan bantuan lanjutan	Rujukan konsultasi profesional difasilitasi secara rahasia sesuai struktur rumah sakit.

4. Rencana Implementasi

4.1 Alur dan Ilustrasi Penerapan

Alur pelaksanaan RESET IGD disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur RESET IGD

Sebagai ilustrasi, setelah kejadian pasien gelisah yang merusak barang berhasil dikendalikan, seorang perawat masih merasakan ketegangan. Dukungan kemudian ditawarkan oleh rekan. Karena kedua perawat masih dibutuhkan, jeda di luar area pelayanan belum dapat diberikan, sehingga dukungan singkat dimulai di tempat ketika tugas memungkinkan. Setelah tugas dapat dicakup, kesempatan jeda diberikan, lalu kesiapan kembali bertugas ditanyakan. Ilustrasi ini merupakan contoh rancangan, bukan hasil penerapan.

4.2 Tahapan dan Jadwal

Program diujicobakan selama empat minggu dalam rangkaian pelaksanaan delapan minggu sejak usulan disetujui. Penanggung jawab pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala IGD atau pejabat yang berwenang, dengan melibatkan perwakilan dokter dan perawat (Tabel 6).

Tabel 6. Tahapan, jadwal, dan penanggung jawab

Tahap	Waktu	Kegiatan	Penanggung jawab	Keluaran
Persiapan	Minggu 1	Alur, batas pelaksanaan, dan jalur bantuan lanjutan disepakati; kartu saku dan poster disusun.	Kepala IGD dan tim pelaksana	Panduan satu halaman dan kesepakatan tim
Pengukuran awal	Minggu 2	Survei singkat mengenai pemicu tekanan, kesempatan jeda, dan dukungan yang dibutuhkan.	Tim pelaksana	Data awal (*baseline*)
Sosialisasi	Minggu 2	Langkah RESET diperkenalkan dan percakapan singkat dilatihkan pada pertemuan rutin atau operan *shift*.	Tim pelaksana	Petugas memahami cara meminta dan menawarkan dukungan
Uji coba	Minggu 3–6	RESET diterapkan pada situasi yang sesuai dan dicatat dalam rekap ringkas.	Penanggung jawab *shift*	Data pemanfaatan dan hambatan
Evaluasi	Minggu 7	Survei anonim, analisis rekap, dan diskusi kendala operasional.	Tim pelaksana	Laporan evaluasi
Tindak lanjut	Minggu 8	Keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki, atau menunda penerapan.	Kepala IGD	Rekomendasi kepada manajemen

4.3 Kebutuhan Sumber Daya dan Biaya

RESET tidak memerlukan aplikasi baru, ruangan baru, maupun pembelian sarana khusus. Sosialisasi dilaksanakan dengan memanfaatkan pertemuan rutin, dan fasilitas istirahat yang sudah ada digunakan. Perkiraan biaya disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Perkiraan kebutuhan biaya

Kebutuhan	Rincian	Perkiraan biaya
Kartu saku RESET	±20 lembar sesuai jumlah petugas IGD, dicetak dan dilaminasi	Rp100.000
Poster alur RESET	2 lembar ukuran A3 untuk ruang jaga	Rp50.000
Formulir rekap dan kuesioner	Dicetak atau disediakan dalam bentuk formulir daring	Rp50.000
Sosialisasi	Dilaksanakan pada pertemuan rutin atau operan *shift*	–
Total		**Rp200.000**

Rincian biaya merupakan perkiraan dan disesuaikan dengan harga yang berlaku.

4.4 Pencatatan dan Kerahasiaan

Rekap hanya memuat tanggal dan *shift*, jenis kejadian, dukungan yang ditawarkan atau diminta, bentuk jeda, skor ketegangan sukarela, dan hambatan operasional (Lampiran 2). Nama petugas, data pribadi pasien, dan isi percakapan tidak dicatat. Pencatatan program tidak menggantikan pelaporan insiden yang berlaku di rumah sakit, dan data tidak digunakan untuk penilaian kinerja individu.

4.5 Antisipasi Hambatan

Tabel 8. Potensi hambatan dan antisipasinya

Potensi hambatan	Antisipasi
Petugas sungkan meminta atau menerima dukungan	Tawaran disampaikan secara pribadi; contoh penerapan diberikan oleh penanggung jawab *shift* dan petugas senior.
Pelayanan terganggu saat jeda	Jeda terpisah hanya diberikan bila tugas tercakup; dukungan di tempat digunakan sebagai pilihan awal.
Langkah RESET terlupa	Kartu saku dibagikan dan poster dipasang di ruang jaga; pengingat disampaikan saat operan *shift*.
Pencatatan dirasa membebani	Rekap dibatasi satu baris per kejadian dan dapat diisi dalam waktu kurang dari satu menit.

4.6 Keberlanjutan

Apabila dinilai layak dan bermanfaat, RESET dimasukkan ke dalam materi orientasi petugas baru dan pengarahan rutin IGD, serta diusulkan untuk ditetapkan sebagai prosedur unit. Kesulitan memperoleh jeda yang terjadi berulang disampaikan kepada manajemen sebagai masukan bagi pengaturan tenaga dan jadwal. Penerapan pada unit lain dengan paparan kejadian bertekanan serupa dapat dipertimbangkan setelah evaluasi di IGD.

5. Indikator Keberhasilan

Evaluasi difokuskan pada kelayakan, penerimaan, dan manfaat sesaat yang dirasakan petugas. Pengisian penilaian bersifat sukarela dan tidak digunakan untuk penilaian kinerja individu. Indikator dan target disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Indikator keberhasilan dan target

Indikator	Cara ukur	Target
Cakupan sosialisasi	Daftar hadir sosialisasi dibandingkan dengan jumlah dokter dan perawat IGD.	≥80% petugas
Pemahaman	Proporsi peserta yang dapat menyebutkan lima langkah dan batas pelaksanaan RESET pada kuis singkat.	≥80% peserta
Pemanfaatan	Proporsi kejadian bertekanan tinggi yang tercatat dengan tawaran atau permintaan dukungan.	≥70% kejadian
Ketegangan sesaat	Skor sukarela 0–10 sebelum dan sesudah dukungan, dianalisis pada pasangan data yang lengkap.	Median penurunan ≥2 poin
Manfaat yang dirasakan	Proporsi responden survei anonim yang menyatakan terbantu; jumlah responden dicantumkan.	≥70% responden
Kesinambungan pelayanan	Jumlah tugas penting yang tidak tercakup akibat pelaksanaan jeda.	0 kejadian
Hambatan jeda	Jumlah dan alasan jeda yang belum dapat diberikan.	Seluruh hambatan tercatat dan dibahas

Program direkomendasikan untuk dilanjutkan apabila sedikitnya lima dari tujuh target tercapai dan tidak ditemukan gangguan terhadap kesinambungan pelayanan. Apabila sebagian target belum tercapai, alur diperbaiki dan uji coba diulang; apabila pelayanan terganggu, penerapan ditunda untuk dikaji ulang.

Target ditetapkan sebagai acuan awal dan dapat disesuaikan setelah pengukuran awal. Skor ketegangan digunakan untuk evaluasi internal, bukan sebagai alat diagnosis, dan perubahan skor tidak dimaksudkan untuk membuktikan efektivitas klinis. Dampak jangka panjang, seperti penurunan *burnout* dan insiden keselamatan pasien, dinilai melalui evaluasi lanjutan apabila program diteruskan.

6. Kesimpulan

RESET IGD diusulkan sebagai solusi atas belum tersedianya dukungan terstruktur bagi petugas IGD RS Mutiara Sukma setelah situasi bertekanan tinggi. Melalui lima langkah, yaitu pengenalan kebutuhan, kepastian kondisi aman, jeda singkat, dukungan emosional, dan pemeriksaan kesiapan kembali bertugas, dukungan diberikan secara cepat tanpa mengorbankan kesinambungan pelayanan. Solusi ini dirancang khusus untuk IGD dengan jumlah tenaga terbatas, dapat dimulai melalui kesepakatan tim dengan perkiraan biaya Rp200.000, dan sesuai dengan kondisi RS Mutiara Sukma. Manfaatnya dinilai melalui uji coba empat minggu dengan indikator yang terukur. Dengan dukungan manajemen, RESET IGD diharapkan dapat segera diujicobakan dan, apabila terbukti layak, dijadikan bagian dari upaya pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja petugas rumah sakit.

Referensi

1. Liu J, Gan Y, Jiang H, Li L, Dwyer R, Lu K, et al. Prevalence of workplace violence against healthcare workers: a systematic review and meta-analysis. Occup Environ Med. 2019;76(12):927–37. doi:10.1136/oemed-2019-105849
2. Hall LH, Johnson J, Watt I, Tsipa A, O'Connor DB. Healthcare staff wellbeing, burnout, and patient safety: a systematic review. PLoS One. 2016;11(7):e0159015. doi:10.1371/journal.pone.0159015
3. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.
4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19.
5. World Health Organization. WHO guidelines on mental health at work. Geneva: World Health Organization; 2022.
6. Edrees H, Connors C, Paine L, Norvell M, Taylor H, Wu AW. Implementing the RISE second victim support programme at the Johns Hopkins Hospital: a case study. BMJ Open. 2016;6(9):e011708. doi:10.1136/bmjopen-2016-011708
7. Walker CA, McGregor L, Taylor C, Robinson S. STOP5: a hot debrief model for resuscitation cases in the emergency department. Clin Exp Emerg Med. 2020;7(4):259–66. doi:10.15441/ceem.19.086
8. World Health Organization, War Trauma Foundation, World Vision International. Psychological first aid: guide for field workers. Geneva: World Health Organization; 2011.

Lampiran 1. Kartu Saku RESET IGD

Kartu berikut dicetak, dilaminasi, dan dibagikan kepada seluruh petugas IGD; versi ukuran A3 dipasang di ruang jaga.

RESET IGD Digunakan setelah situasi berat terkendali	
R	***Recognize* — Kenali** Kebutuhan dukungan disampaikan atau ditawarkan. *"Tadi cukup berat. Ada yang bisa kubantu?"*
E	***Ensure safety* — Pastikan aman** Situasi aman dan tugas tercakup sebelum meninggalkan area. *"Pasienmu aku pantau dulu, ya."*
S	***Short pause* — Jeda singkat** Jeda 3–5 menit bila tugas tercakup; bila belum, dukungan dimulai di tempat. *Duduk, minum, tarik napas perlahan.*
E	***Emotional support* — Dukung** Bantuan praktis ditawarkan; didengarkan tanpa dipaksa bercerita. *"Mau cerita boleh, mau diam juga boleh."*
T	***Transition* — Kembali bertugas** Kesiapan ditanyakan; bantuan lanjutan diatur bila perlu. *"Sudah siap lanjut, atau masih perlu bantuan?"*
Sukarela • Rahasia • Pelayanan tetap tercakup Bila petugas tidak mampu melanjutkan tugas dengan aman, penanggung jawab *shift* segera dihubungi.	

Lampiran 2. Formulir Rekap dan Kuesioner Evaluasi

A. Formulir Rekap RESET IGD (diisi oleh penanggung jawab shift)

No	Tanggal/ *shift*	Kode kejadian[1]	Dukungan ditawarkan/ diminta (Y/T)	Bentuk jeda[2]	Skor sebelum (0–10)	Skor sesudah (0–10)	Hambatan operasional
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

[1] Kode kejadian: A = pasien gelisah/agresif; K = keluarga dengan emosi tinggi; B = kejadian pelayanan berat lainnya. [2] Bentuk jeda: D = dukungan di tempat; T = jeda terpisah; J = jeda dijadwalkan ulang; – = tidak ada jeda. Nama petugas, data pribadi pasien, dan isi percakapan tidak dicatat.

B. Kuesioner Evaluasi Anonim (diisi oleh petugas setelah uji coba)

Petunjuk: lingkari angka yang paling sesuai. 1 = sangat tidak setuju; 2 = tidak setuju; 3 = ragu-ragu; 4 = setuju; 5 = sangat setuju.

No	Pernyataan	Penilaian
1	Langkah RESET mudah dipahami.	1 2 3 4 5
2	Saya merasa nyaman meminta atau menawarkan dukungan kepada rekan.	1 2 3 4 5
3	Dukungan yang diterima membantu saya kembali tenang dan siap bertugas.	1 2 3 4 5
4	Pelaksanaan RESET tidak mengganggu pelayanan pasien.	1 2 3 4 5
5	RESET perlu dilanjutkan di IGD.	1 2 3 4 5
6	Hambatan dan saran: ……	

Respons dinyatakan “terbantu” apabila pernyataan nomor 3 dinilai 4 atau 5.